Gefördert durch:

Gemeinsamer Bundesausschuss
Innovationsausschuss
Förderkennzeichen: 01NVF2114

iamag
Institut für Allgemeinmedizin und Ambulante Gesundheitsversorgung

imvr
Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaften

ENTLASSMANAGEMENT MITGESTALTEN

Befragung von Hausärztinnen und Hausärzten bezüglich Barrieren und Chancen des Entlassmanagements multimorbider Patient:innen

4773137967

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

nicht selten kommt es vor, dass Ihre älteren Patient:innen mit Multimorbidität und internistischen Problemen bereits wenige Tage oder Wochen nach einem ungeplanten Klinikaufenthalt erneut stationär aufgenommen werden müssen. Zu den Gründen für solche Re-Hospitalisierungen gehört manchmal ein nicht optimales Entlassmanagement. Als Hausärztin / Hausarzt können Sie uns wertvolle Anregungen zur Verbesserung der ambulant-stationären Schnittstelle geben. Ihre Erfahrungen zu den Herausforderungen helfen uns, die bestehenden Probleme besser zu verstehen, um Ihren Praxisalltag zu erleichtern und die Versorgung von Patient:innen zu verbessern.

Befragungsteilnahme: Wir möchten Sie bitten, den vorliegenden Fragebogen möglichst vollständig auszufüllen. Die Befragung ist komplett anonym. Für die Rücksendung liegt ein frankierter Umschlag bei. Für Sie entstehen keinerlei Kosten.

Datenschutz: Die Befragung wird vom Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVR) der Universität zu Köln in Zusammenarbeit mit dem Institut für Allgemeinmedizin und Ambulante Gesundheitsforschung (iamag) der Universität Witten/Herdecke durchgeführt. Alle von Ihnen gemachten Angaben sind freiwillig und werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Verarbeitung und Analyse Ihrer Angaben aus dem Fragebogen erfolgen anonym und nur zu wissenschaftlichen Zwecken im IMVR der Universität zu Köln. Ihre Adressdaten stammen aus einer Zufallsstichprobe aus dem Bundesarztregister. Die Befragung wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln genehmigt und positiv bewertet (Votumsnr. 23-1232).

Wir freuen uns auf Ihre Fragen oder Rückmeldungen: Kai Keller steht Ihnen als verantwortlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter zur Verfügung (Kontakt: kai.keller@uk-koeln.de; +49 221 478-97158).

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens: In dem vorliegenden Fragebogen werden Sie um Ihre Meinung zu verschiedenen Fragen oder Aussagen gebeten. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Am Ende des Fragebogens finden Sie ein Freitextfeld, um uns alle weiteren Anmerkungen mitzuteilen.
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 15-20 Minuten.

- *Antworten Sie bitte offen und ehrlich.*
- *Lesen Sie die Fragen sorgfältig durch. Gehen Sie aber bei der Beantwortung zügig durch. Meist ist der erste spontane Einfall der stimmigste.*
- *Bitte beachten Sie die wechselnden Antwortkategorien.*
- *Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile nur eine Antwort an.*

Wie ausfüllen?	stimme überhaupt nicht zu	stimme eher nicht zu	stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
So kreuzen Sie richtig an:	☐	☐	☒	☐
Falls Sie Ihre Meinung ändern wollen:	☒	☐	■	☐

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

6633137964

Ambulant-stationäre Schnittstelle

1. Austausch zwischen ambulantem und stationärem Sektor

Wenn Sie an die Entlassungen Ihrer älteren multimorbiden Patient:innen denken, wie oft müsste das Entlassmanagement besser laufen?				
Sehr selten	Selten	Manchmal	Häufig	Sehr häufig
☐	☐	☐	☐	☐

Wie viele verschiedene Krankenhäuser behandeln in der Regel Ihre älteren multimorbiden Patient:innen mit internistischen Problemen? *Bitte schätzen Sie die Anzahl*	☐☐ *Krankenhäuser*

Wichtig: Bitte beziehen Sie sich bei der Beantwortung der folgenden Fragen auf Ihre Erfahrungen mit den/der internistischen Klinikabteilung/en des Krankenhauses, welches Ihre älteren multimorbiden Patient:innen mit internistischen Problemen am häufigsten betreut.

Wir fragen explizit nach internistischen Abteilungen, da für andere relevante Krankenhausabteilungen, wie z.B. die Geriatrie, andere Versorgungsstandards etabliert sind.

Wie viele Ihrer älteren, multimorbiden Patient:innen mit internistischen Problemen werden durchschnittlich pro Monat aus diesem Krankenhaus nach Hause entlassen? *Bitte schätzen Sie die Anzahl*	☐☐☐ *Patient:innen*
Bei wieviel Prozent dieser Patient:innen findet ein direkter kollegialer Austausch zwischen Ihnen und den Klinikärzt:innen (z.B. über Telefon) statt?	☐☐☐ %
Wieviel Prozent dieses Austausches wird durch die Klinikärzt:innen initiiert?	☐☐☐ %
Welche/n direkten Kommunikationsweg/e bevorzugen Sie für diesen Austausch mit Klinikärzt:innen? *Mehrfachauswahl möglich*	☐ Telefonat ☐ E-Mail ☐ Messenger Dienst ☐ KIM ☐ Videokonferenz ☐ Persönliches Treffen ☐ Fax ☐ Sonstiger: _____
Sind Sie außerhalb Ihrer regulären Arbeitszeit für die Klinikärzt:innen erreichbar?	☐ Ja ☐ Nein

Gemeinsame Veranstaltungen wie Diskussionsforen, Stammtische, Qualitätszirkel oder Praxisbesuche können dazu beitragen, miteinander in Kontakt zu treten, sich zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu besprechen.	
Bitte bewerten Sie die aktuellen Gelegenheiten für den Austausch zwischen Ihnen und den Klinikärzt:innen des besagten Krankenhauses.	☐ Es gibt keine Gelegenheiten für den Austausch ☐ Es gibt wenige Gelegenheiten für den Austausch ☐ Es gibt einige Gelegenheiten für den Austausch ☐ Es gibt viele Gelegenheiten für den Austausch
Falls es gemeinsame Veranstaltungen für den Austausch gibt, nehmen Sie an diesen Teil?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Es gibt keine gemeinsamen Veranstaltungen

8929137964

2. Versorgungskoordination an der ambulant-stationären Schnittstelle

Bitte beziehen Sie sich beim Beantworten der folgenden Fragen weiterhin auf die internistische/n Klinikabteilung/en des Krankenhauses, welches Ihre älteren multimorbiden Patient:innen mit internistischen Problemen am häufigsten betreut.

Achten Sie bei der Beantwortung dieser Fragen darauf, dass Sie alle Formen der Kommunikation mit den Klinikärzt:innen der besagten Klinikabteilung/en berücksichtigen, einschließlich Arztbriefe, persönliche Treffen, Telefonate, E-Mails usw.					
Wie häufig kommunizieren Klinikärzt:innen mit Ihnen über die Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Nicht annähernd genug ☐	Nicht genug ☐	Genau im richtigen Maß ☐	Zu oft ☐	Viel zu oft ☐
Kommunizieren die Klinikärzt:innen mit Ihnen zum richtigen Zeitpunkt über die Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Nie ☐	Selten ☐	Manchmal ☐	Häufig ☐	Immer ☐
Kommunizieren die Klinikärzt:innen inhaltlich präzise mit Ihnen über die Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Nie ☐	Selten ☐	Manchmal ☐	Häufig ☐	Immer ☐
Wenn es ein Problem mit der Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen gibt, machen die Klinikärzt:innen andere für die Lösung verantwortlich oder arbeiten sie mit Ihnen zusammen, um das Problem zu lösen?	Machen immer andere verantwortlich ☐	Machen meistens andere verantwortlich ☐	Weder noch ☐	Lösen das Problem meistens zusammen ☐	Lösen das Problem immer zusammen ☐
Teilen Klinikärzt:innen Ihre Ziele bezogen auf die Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Überhaupt nicht ☐	Ein wenig ☐	Teilweise ☐	Größtenteils ☐	Voll und ganz ☐
Wie viel wissen Klinikärzt:innen über Ihre Arbeit bei der Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Nichts ☐	Wenig ☐	Etwas ☐	Viel ☐	Alles ☐
Respektieren Klinikärzt:innen Ihre Arbeit bei der Behandlung Ihrer gemeinsamen Patient:innen?	Überhaupt nicht ☐	Ein wenig ☐	Teilweise ☐	Größtenteils ☐	Voll und ganz ☐

3. Ihr Verhältnis zu den Klinikärzt:innen der besagten Klinikabteilung(en)

Was ist ihr Eindruck?	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
Die Klinikärzt:innen halten sich für etwas Besseres	☐	☐	☐	☐
Die Klinikärzt:innen verhalten sich mir gegenüber arrogant	☐	☐	☐	☐
Die Klinikärzt:innen informieren nur auf Anfrage	☐	☐	☐	☐
Die Klinikärzt:innen vergessen schon einmal ein Anliegen, was man hat	☐	☐	☐	☐
Die Klinikärzt:innen haben zu wenig Zeit für mich	☐	☐	☐	☐

7276137968

4. Informationsübermittlung und Absprachen beim Entlassmanagement

Wie häufig treten die folgenden Szenarien im Entlassprozess des besagten Krankenhauses auf?												
In wie viel Prozent der Fälle kommt es vor, dass...	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	**Weiß nicht**
Sie vor der Entlassung für die Behandlungsplanung Ihrer Patient:innen kontaktiert werden?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
die Einleitung pflegerischer oder sozialer Hilfe mit Ihnen abgestimmt wird?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sie im Entlassbrief unvollständige Informationen erhalten, die eine kontinuierliche Weiterversorgung beeinträchtigen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sie als Ärzt:in sich mit Rückfragen zum Entlassbrief an eine/einen der Klinikärzt:innen wenden?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sie keine Rufnummer einer zuständigen ärztlichen Ansprechperson für Rückfragen haben?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sie eine Ansprechperson nach Entlassung erreichen wollen und es Ihnen nicht gelingt?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sie die Medikation aus der Klinik unverändert übernehmen können?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sie die aus der Klinik verordneten Medikamente nicht inhaltlich nachvollziehen können?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Wie oft würden Sie sich wünschen…	Deutlich häufiger als aktuell	Etwas häufiger als aktuell	Gleich häufig wie aktuell	Etwas seltener als aktuell	Deutlich seltener als aktuell	Wünsche ich mir nicht
bezüglich der Behandlungsplanung Ihrer Patient:innen vor der Entlassung kontaktiert zu werden?	☐	☐	☐	☐	☐	☐
dass die Einleitung pflegerischer oder sozialer Hilfe mit Ihnen abgestimmt wird?	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ein neues Versorgungskonzept für das Entlassmanagement

Um den Herausforderungen an der ambulant-stationären Schnittstelle bei der Entlassung von älteren, multimorbiden Patient:innen zu begegnen, soll ein innovatives Versorgungskonzept entworfen werden. Ziel ist es, akute Rehospitalisierungen (Drehtüreffekt) zu vermeiden.

Hierzu ist eine zielgerichtete Unterstützung älterer, multimorbider Patient:innen in den ersten 6 Wochen nach der Entlassung nach Hause geplant. Das Konzept soll sektorenübergreifende Fallkonferenzen, Fallmanager:innen und Smart Devices für Patient:innen beinhalten. Diese werden im weiteren Verlauf des Fragebogens einzeln vorgestellt.

Da Ihre Rolle als Hausärzt:in entscheidend für die ambulante Weiterversorgung ist, interessieren uns Ihre Einschätzung und Ihre Vorschläge für die Ausgestaltung dieses Konzeptes.

Interdisziplinärer, sektorenübergreifend entwickelter Behandlungsplan

Fallmanager:innen für die individuelle Betreuung und Versorgungskoordination

Smart Devices für das Selbstmanagement der Patient:innen und die telemedizinische Betreuung

5. Sektorenübergreifende Behandlungs- und Medikationsplanung

Was sind die Ziele?

› Gemeinsame Entwicklung eines personalisierten Behandlungs- und Medikationsplans sowie Vorbereitung der Entlassung

Zu welchem Zeitpunkt?

› Während des stationären Aufenthaltes oder bei akuten komplexen Problemen im häuslichen Umfeld nach Entlassung

Wie wird die Behandlungsplanung durchgeführt?

› Als Video- oder Telefonkonferenz

Wer ist an der Behandlungsplanung beteiligt?

› Sie und die Klinikärzt:innen
› Bei Bedarf: Fallmanager:innen, Therapieberufe, Krankenhausapotheke

Gedankenexperiment: Sie haben die Option, die Behandlung und Medikation Ihrer hospitalisierten, älteren, multimorbiden Patient:innen mit dem stationären Behandlungsteam gemeinsam abzustimmen. **Ich wäre bereit, an der Behandlungs- und Medikationsplanung teilzunehmen.**			
Stimme überhaupt nicht zu ☐	Stimme eher nicht zu ☐	Stimme eher zu ☐	Stimme voll und ganz zu ☐
Bei *„Stimme überhaupt nicht zu“*, weiter mit dem **Themenblock 6**: **„Fallmanager:innen und telemedizinische Betreuung“**	➡ *Bitte weiter mit der nächsten Frage*		

Wie sollte die gemeinsame Behandlungs- und Medikationsplanung am besten durchgeführt werden?	☐ Als Videokonferenz ☐ Als Telefonkonferenz ☐ Als persönliches Treffen ☐ Anders, und zwar: _____
Wie lange denken Sie dauert eine effektive Besprechung je Patient:in durchschnittlich?	☐☐ Minuten
Wie hoch müsste diese Besprechung zur Behandlungs- und Medikationsplanung zusätzlich vergütet werden?	☐☐☐ *€ / Besprechung je Patient:in*

Wie sehr stimmen Sie folgender Aussage zu: Eine gemeinsam zwischen Ihnen und dem Behandlungsteam aus der Klinik interdisziplinär abgestimmte Medikation bietet einen Mehrwert für die Patient:innen (z.B. Sicherstellung der kontinuierlichen Versorgung, Einbeziehen von Erkenntnissen aus dem Klinikaufenthalt).				
Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Neutral	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
☐	☐	☐	☐	☐

6. Fallmanager:innen und telemedizinische Betreuung durch Smart Devices

› Die Betreuung beginnt im Krankenhaus und endet 6 Wochen nach Entlassung, die Smart Devices werden von den Patient:innen zuhause genutzt

Welche Aufgaben haben Fallmanager:innen?

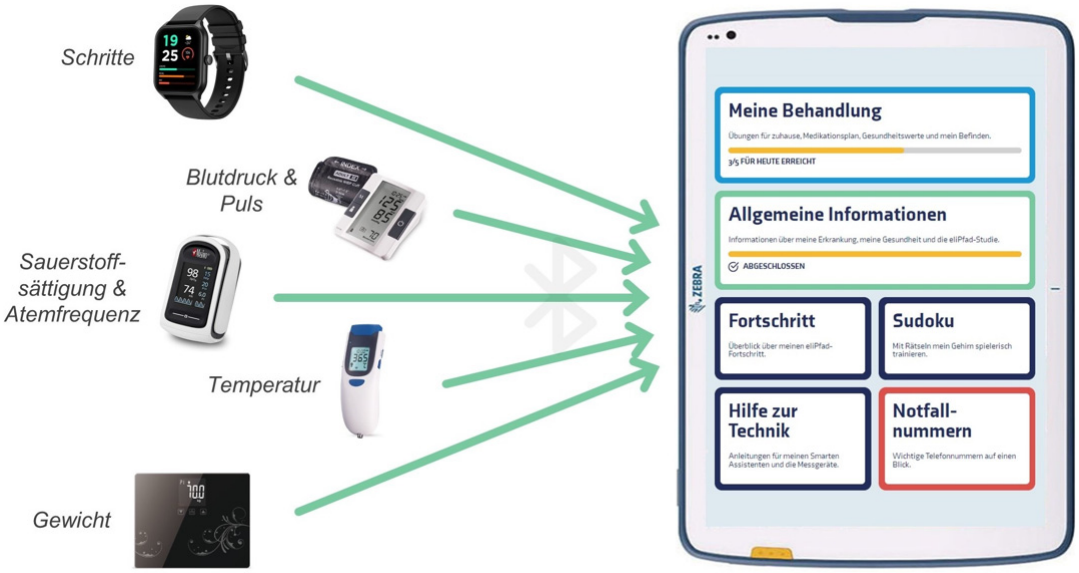
› (sektorenübergreifende) Koordination der Behandlungsplanung und der Leistungserbringer:innen, Terminabstimmungen
› Unterstützung bei der Umsetzung von Behandlungsplänen und des Selbstmanagements
› Überwachung und Dokumentation des Behandlungsverlaufs → Erstellung eines wöchentlichen Statusberichtes zum Gesundheitszustand der Patient:innen

Wie betreuen Fallmanager:innen die Patient:innen?

› Schulung in der Nutzung der Smart Devices (bereits im Krankenhaus) sowie Unterstützung bei der Anwendung zuhause
› 1. Hausbesuch nach Entlassung erfolgt spätestens am Ende der nachfolgenden Kalenderwoche
› 1x/Woche: Telefonkontakt oder Videokonferenz zur Erfassung des Allgemeinzustandes
› 2x/Woche: Monitoring der durch Smart Devices erfassten Vitalparameter

Wie funktioniert die telemedizinische Betreuung mit Smart Devices?

› Patient:innen messen mit Hilfe der unten dargestellten Smart Devices individuell ausgewählte Vitalparameter (z.B. *Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz, Temperatur, Gewicht*)
› Das Tablet beinhaltet u.a. ein Symptomtagebuch für Patient:innen, individuelle Bewegungsübungen und edukatives Material für das Selbstmanagement zuhause
› Die erfassten Daten werden durch das Tablet automatisch und datenschutzkonform übermittelt



Wie werden Sie als Hausärzt:in eingebunden?

› Sie erhalten einen wöchentlichen Statusbericht mit den erhobenen Vitalparametern, einer Einschätzung des Allgemeinzustandes (durch Fallmanager:innen), Änderungen des Medikationsplanes und Angaben des Symptomtagebuchs
› Bei Abweichungen von vordefinierten Grenzwerten der Vitalparameter oder gesundheitlichen Auffälligkeiten werden Sie durch Fallmanager:innen kontaktiert
› Bei Bedarf können Sie die erfassten Vitalparameter tagesaktuell online einsehen

3122137964

6.1 Fallmanager:innen für die Patientenbetreuung und Schnittstellenkoordination

Gedankenexperiment: Ihre Patient:innen haben für die ersten 6 Wochen nach Krankenhausentlassung eine/n Fallmanager:in zur Unterstützung an die Hand bekommen. Wie stehen Sie zu Fallmanager:innen?

Ich wäre bereit, mich mit den Fallmanager:innen abzustimmen.

Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
☐	☐	☐	☐

Wann sollte der erste Hausbesuch durch die Fallmanager:innen spätestens erfolgen, um Ihnen die Arbeit in der Nachsorge zu erleichtern?	☐☐ *Tag(e) nach Krankenhausentlassung*

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zum Einsatz von Fallmanager:innen zu?	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
Fallmanager:innen kennen die Krankheitshistorie der Patient:innen nicht gut genug, um deren Gesundheitszustand auf Handlungsbedarf hin einschätzen zu können.	☐	☐	☐	☐
Ich befürchte, dass den Patient:innen medizinisch unnötige Hilfen oder Behandlungen durch die Fallmanager:innen empfohlen werden.	☐	☐	☐	☐
Eine Unterstützung der Patient:innen bei der Beschaffung, Lagerung und Anwendung von Arzneimitteln wäre eine sinnvolle Ergänzung im ambulanten Medikationsprozess.	☐	☐	☐	☐

Wie wichtig ist es Ihnen als Hausärzt:in, die Unterstützung von Fallmanager:innen für einzelne Patient:innen zu initiieren oder beenden zu können?

Sehr wichtig	Wichtig	Neutral	Weniger wichtig	Gar nicht wichtig	**keine Angabe**
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Welche Aufgaben könnten die Fallmanager:innen übernehmen, um die nachstationäre Versorgung Ihrer Patient:innen zu unterstützen?

*Kreuzen Sie bitte **3** Aufgaben an, die aus Ihrer Sicht am wichtigsten sind:*

- ☐ Koordination der Entlassung gemeinsam mit den Patient:innen und dem Behandlungsteam
- ☐ Beratung und Schulung von Patient:innen und Angehörigen zu Selbstpflege und Krankheitsmanagement
- ☐ Koordination von Unterstützungsdiensten und sozialen Dienstleistungen
- ☐ Planung und Organisation von ambulanten Therapien oder Rehabilitationsmaßnahmen
- ☐ Überwachung von Vitalparametern und Rückmeldung an das Behandlungsteam
- ☐ Identifikation von Risikofaktoren und frühzeitiges Eingreifen bei Verschlechterung des Gesundheitszustands
- ☐ Regelmäßige Überprüfung des Medikamentenplanes
- ☐ Überprüfung, ob die häusliche Situation den Bedarfen der Patient:innen entspricht
- ☐ Förderung der Einhaltung von Therapieplänen und medizinischen Empfehlungen
- ☐ Etwas anderes, und zwar: _____

Wenn Sie an Ihre älteren, multimorbiden Patient:innen denken, in wie viel Prozent der Fälle wäre die Unterstützung durch Fallmanger:innen hilfreich? *Bitte schätzen Sie*	☐☐☐ %

6.2 Telemedizinische Betreuung durch Smart Devices

Gedankenexperiment: Einige Ihrer Patient:innen haben für die ersten 6 Wochen nach Krankenhausentlassung Smart Devices erhalten und Sie haben die Möglichkeit das dargestellte telemedizinische Monitoring (wöchentlicher Statusbericht, Einsicht in Vitalparameter, Benachrichtigung durch Fallmanager:innen) zu nutzen. Würden Sie daran teilnehmen?

Ich wäre bereit, für diese Patient:innen die telemedizinische Betreuung zu übernehmen.

Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
☐	☐	☐	☐

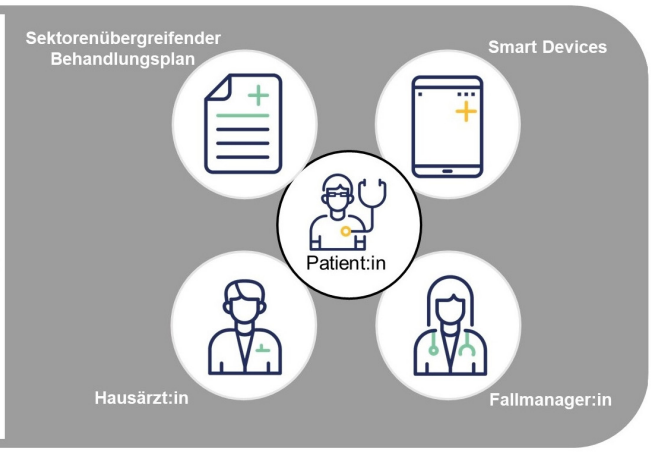
Bitte beziehen Sie sich auf die telemedizinische Betreuung <u>mit Smart Devices in den ersten 6 Wochen nach Krankenhausentlassung</u>.	
Wenn Sie an Ihre älteren, multimorbiden Patient:innen denken, in <u>wie viel Prozent der Fälle</u> fänden Sie die telemedizinische Betreuung hilfreich? *Bitte schätzen Sie*	☐☐☐ %
Wenn Sie die Wahl hätten, in welcher <u>Frequenz</u> sollte das Monitoring der Vitalparameter von den Fallmanger:innen durchgeführt werden, um rechtzeitig auf Abweichungen reagieren zu können?	☐ Mehrmals täglich ☐ Täglich ☐ Jeden 2. Tag ☐ Mehrmals pro Woche ☐ Wöchentlich ☐ Andere Frequenz: _____
Würden Sie das Monitoring der Vitalparameter in Ihrer Praxis auch ohne die Fallmanager:innen übernehmen?	☐ Ja ☐ Vielleicht ☐ Nein
Auf welchem Weg würden Sie den <u>wöchentlichen Statusbericht</u> am liebsten erhalten? *Mehrfachauswahl möglich*	☐ E-Mail ☐ Brief ☐ Fax ☐ KIM ☐ Ansicht in einer Online-Plattform ☐ Ansicht in meiner Praxisverwaltungssoftware ☐ Einem anderen, und zwar: _____
Auf welchem Weg sollten Fallmanager:innen Sie bei <u>medizinischen Auffälligkeiten</u> Ihrer Patient:innen <u>kontaktieren</u>?	☐ E-Mail ☐ Fax ☐ KIM ☐ Praxistelefon ☐ Diensthandy ☐ Privathandy ☐ Einem anderen, und zwar: _____

Wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu den Smart Devices zu?	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
Ich habe Sorge vor einem erhöhten Arbeitsaufwand durch Rückfragen von Patient:innen zu den Smart Devices.	☐	☐	☐	☐
Ich würde das Monitoring der Vitalparameter nicht durchführen, da dies eine grenzüberschreitende Überwachung von Patient:innen darstellt.	☐	☐	☐	☐

3404137967

7. Das Versorgungskonzept als Ganzes

Die vorgestellten Komponenten (sektorenübergreifende Behandlungsplanung, telemedizinische Betreuung mit Smart Devices und die koordinierenden Fallmanager:innen) bauen aufeinander auf und ergänzen sich in ihrer Funktion.
Bitte beziehen Sie sich im folgenden Abschnitt auf das vorgestellte Versorgungskonzept als Ganzes.



Gedankenexperiment: Eine Klinik möchte das vorgestellte Versorgungskonzept für Ihre älteren, multimorbiden Patient:innen umsetzen.Wie stehen Sie zu der Anwendung des Konzeptes?

Ich wäre bereit, das Konzept mit allen Bausteinen in meiner Versorgung zu erproben.

Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
☐	☐	☐	☐

Wer sollte berechtigt sein, das Versorgungskonzept für die Patient:innen zu initiieren? *Mehrfachauswahl möglich*	☐ Klinikärzt:in ☐ Hausärzt:in ☐ Fallmanager:innen ☐ Der Einschluss sollte nur nach gemeinsamer Absprache erfolgen ☐ Weitere: _____

Wie schätzen Sie die Auswirkungen des vorgestellten Versorgungskonzeptes auf die nachfolgenden Aspekte ein?

Bitte nutzen Sie den Status quo des Entlassmanagements von älteren, multimorbiden Patient:innen als Referenz.

Zeitaufwand für Ihre Praxis				
Geringer	Etwas geringer	Gleich	Etwas höher	Höher
☐	☐	☐	☐	☐

Bürokratieaufwand für Ihre Praxis				
Geringer	Etwas geringer	Gleich	Etwas höher	Höher
☐	☐	☐	☐	☐

Verfrühte („blutige“) Krankenhausentlassung von Patient:innen				
Wird seltener	Wird eher seltener	Bleibt gleich	Wird eher häufiger	Wird häufiger
☐	☐	☐	☐	☐

Ungeplante Rehospitalisierung von Patient:innen (Drehtüreffekt)				
Wird verhindert	Wird eher verhindert	Bleibt gleich	Wird eher verstärkt	Wird verstärkt
☐	☐	☐	☐	☐

Wie groß schätzen Sie den potenziellen Nutzen des vorgestellten Versorgungskonzepts für Ihre internistischen Patient:innen nach Klinikentlassung ein?

Kein Nutzen	Geringer Nutzen	Mittlerer Nutzen	Großer Nutzen	Weiß nicht
☐	☐	☐	☐	☐

1618137962

In welchem der vorgestellten Bestandteile sehen Sie das meiste Potenzial zur Verbesserung des Entlassmanagements an der ambulant-stationären Schnittstelle?	☐ Sektorenübergreifende Behandlungspläne ☐ Fallmanager:innen ☐ Telemedizinische Betreuung ☐ Das Konzept als Ganzes (sektorenübergreifende Behandlungsplanung, Fallmanager:innen, Smart Devices) ☐ Ich sehe kein Potenzial zur Verbesserung ☐ Etwas anderes, und zwar: _____

8. Angaben zu der Praxis, in der Sie tätig sind

Bei meiner Praxis handelt es sich um...	☐ Eine Einzelpraxis ☐ Eine Praxisgemeinschaft ☐ Eine Berufsausübungsgemeinschaft (Gemeinschaftspraxis) ☐ Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) ☐ Keine Angabe	
In welcher Region befindet sich die Praxis, in der Sie tätig sind?	☐ Landgemeinde (≤ 5000 Einwohner:innen) ☐ Kleinstadt (> 5000-20.000 Einwohner:innen) ☐ Mittelstadt (> 20.000-100.000 Einwohner:innen) ☐ Großstadt (> 100.000 Einwohner:innen)	
In welchem Bundesland befindet sich die Praxis, in der Sie tätig sind?	☐ Baden-Württemberg ☐ Bayern ☐ Berlin ☐ Brandenburg ☐ Bremen ☐ Hamburg ☐ Hessen ☐ Mecklenburg-Vorpommern	☐ Niedersachsen ☐ Nordrhein-Westfalen ☐ Rheinland-Pfalz ☐ Saarland ☐ Sachsen ☐ Sachsen-Anhalt ☐ Schleswig-Holstein ☐ Thüringen
Wie viele Ärzt:innen arbeiten in Ihrer Praxis (Sie selbst und Weiterbildungsassistent:innen miteingeschlossen)?	*umgerechnet in Vollzeitkräfte:* ☐☐	
Wie viel nicht ärztliches Personal (MFA, Praxismanager:innen) arbeitet in ihrer Praxis?	*umgerechnet in Vollzeitkräfte:* ☐☐	

9. Angaben zu Ihrem Beruf

Sind Sie in einem Angestelltenverhältnis tätig?	☐ Ja ☐ Nein
Wie viele Stunden arbeiten Sie durchschnittlich pro Woche?	☐☐ *Stunden pro Woche*
Wie hoch ist Ihre persönliche durchschnittliche Behandlungsfallzahl (Scheine) pro Quartal?	☐☐☐☐ *Scheine pro Quartal*
Wie viel Prozent Ihrer Patient:innen sind älter und multimorbide?	☐☐ %

Wie viele dieser Patient:innen sind „Drehtür-Patient:innen“?
(Personen, die häufig und ungeplant akut rehospitalisiert werden)

Keine	Wenige	Einige	Viele	Sehr viele
☐	☐	☐	☐	☐

1979137962

Wie viele Hausbesuche führen Sie selbst durchschnittlich pro Woche durch? *Wenn Sie keine Hausbesuche durchführen, tragen Sie eine „0“ ein*	☐☐ *pro Woche*
Führen Sie selbst für Ihre eigenen Patient:innen im Bedarfsfall Hausbesuche am Wochenende durch?	☐ Ja ☐ Nein
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Hausärztin/Hausarzt?	☐☐ *Jahre*
Wie viele Jahre haben Sie bisher im stationären Sektor gearbeitet? *Wenn Sie nie stationär tätig waren, tragen Sie eine „0“ ein*	☐☐ *Jahre*
Welche fachärztliche Weiterbildung haben Sie? *Mehrfachauswahl möglich*	☐ Ärztin/Arzt in Weiterbildung ☐ Praktische Ärztin/Praktischer Arzt ☐ Fachärztin/Facharzt für Allgemeinmedizin ☐ Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin ☐ Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin ☐ Sonstige: _____

10. Ihre Arbeitsbelastung

Berufliches Burnout bedeutet, sich körperlich, mental und emotional erschöpft zu fühlen.
Bitte kreuzen Sie das Streichholz an, welches am besten darstellt, wie ausgebrannt Sie sich derzeit fühlen.

Muir Matches Measure © Copyright: Cindy Muir

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

11. Angaben zu Ihrer Person

Wie alt sind Sie?	☐ 30 Jahre oder jünger ☐ 31 bis 40 Jahre ☐ 41 bis 50 Jahre ☐ 51 bis 60 Jahre ☐ über 60 Jahre
Mit welchem Geschlecht identifizieren Sie sich?	☐ männlich ☐ weiblich ☐ weiteres ☐ keine Angabe

Ihre Anmerkungen

Möchten Sie uns noch etwas anderes mitteilen? Hier ist Platz für Ihre Anmerkungen:

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen in dem beiliegenden frankierten Rückumschlag an uns zurück.

4512137968